

# Clinica Geral Sp Temp

## Resumed™ - Cirurgia Geral São Paulo

### Introdução

Bem-vindo ao Resumed™ de **Cirurgia Geral**! Este guia é um auxílio valioso para estudantes que pretendem se preparar para as provas R1 em instituições como USP-SP, Unifesp, Unicamp, Santa Casa e SUS-SP. Neste conteúdo, você encontrará informações práticas e atualizadas sobre os principais temas de Cirurgia Geral, organizados em capítulos claros e fáceis de seguir.

### Trauma

## Avaliação Inicial – ABCDE

Avalie o paciente com a sequência ABCDE:

- A: Vias aéreas + proteção cervical
- B: Ventilação – inspeção, oximetria, ausculta
- C: Circulação – pulso, perfusão, reposição volêmica
- D: Déficit neurológico – escala de Glasgow
- E: Exposição – despir o paciente, prevenir hipotermia

## Choque

Classifique o choque com base na perda de volume:

- I: perda <15% → sem alteração
- II: 15–30% → FC↑, PA normal
- III: 30–40% → PA ↓, confusão
- IV: >40% → confusão, choque grave

Conduta: 2 acessos periféricos + cristalóide 1-2 L → sangue se refratário

## **Trauma Cranioencefálico (TCE)**

Avalie o paciente com base na escala de Glasgow:

- <8: intubação Sinais de HIC: bradicardia + hipertensão + irregularidade respiratória (tríade de Cushing) Conduta: TC, neurocirurgia, manitol se HIC, evitar hiperventilação prolongada

## **Trauma Torácico**

Avalie o paciente com base na instabilidade do tórax:

- Tórax instável (voo de costela): dor, dispneia → drenagem e suporte Pneumotórax hipertensivo: descompressão com agulha + dreno em selo d'água Hemotórax: dreno; se >1500 mL → toracotomia

## **Trauma Abdominal**

Avalie o paciente com base nos sinais de irritação peritoneal:

- Sinais de irritação peritoneal = laparotomia FAST positivo + instável = cirurgia Lesão de baço/fígado: observação se estável, cirurgia se instável

### **Aonde?**

Essas são as regras para avaliar e tratar os pacientes com trauma! Lembre-se de que a prioridade é sempre a vida do paciente.

---

### **Abdome Agudo**

## Apendicite Aguda

Avalie o paciente com base nos sintomas:

- Dor em FID, sinal de Blumberg, febre, leucocitose USG ou TC confirmam Conduta: apendicectomia (laparoscópica se possível)

## Colecistite Aguda

Avalie o paciente com base nos sintomas:

- Dor em HD, Murphy positivo USG: espessamento da parede + cálculo + líquido Conduta: antibiótico + colecistectomia precoce

## Pancreatite Aguda

Avalie o paciente com base nos sintomas:

- Dor em barra, vômito, amilase/lipase ↑ Classificação de Atlanta Conduta: hidratação + analgesia ATB só se necrose infectada

## Perfuração de víscera oca

Avalie o paciente com base nos sintomas:

- Dor intensa + pneumoperitônio Rx com ar sob diafragma Conduta: laparotomia + rafia

## Hérnias

## Inguinal

Diferencie entre hérnia direta e indireta:

- Indireta (mais comum): anel inguinal interno → externo  
Direta: fraqueza da parede posterior (Hesselbach) Tto: hernioplastia de Lichtenstein (tela)

## Complicada

Avalie o paciente com base nos sintomas:

- Encarcerada: irreduzível, sem sinais de isquemia  
Estrangulada: dor intensa + sinais de sofrimento → cirurgia de urgência

### Cuidados Perioperatórios

## Avaliação Pré-operatória

Avalie o paciente com base nos exames:

- Exames: hemograma, ECG se >40 anos, glicemia, função renal  
Risco cardiovascular: Escore de Goldman ou ASA

## Jejum

Recomende o jejum para pacientes com cirurgia programada:

- 6h sólidos leves / 2h líquidos claros Jejum prolongado = risco  
↑ de hipoglicemia, hipotensão

## Profilaxia de TEP

Avalie o paciente com base no risco:

- Baixo risco: deambulação precoce Moderado/alto risco: heparina + meias elásticas

## Antibioticoprofilaxia

Recomende a antibioticoprofilaxia para pacientes com cirurgia programada:

- Cefazolina (1ª escolha) Iniciar até 1h antes da incisão

## Queimaduras

## Avaliação da extensão

Avalie o paciente com base na regra dos 9:

- Regra dos 9 (adulto):
  - Cabeça: 9%
  - Tronco ant/post: 18% cada
  - Membro superior: 9% cada
  - Membro inferior: 18% cada
  - Genitália: 1%

## Conduta inicial

Avalie o paciente com base nos sintomas:

- ABCDE Parkland:
    - $4 \text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{ SCQ} \rightarrow 1^{\text{a}}$  metade nas primeiras 8h
- Indicação de internação:
- $>10\%$  SCQ em crianças
  - $>20\%$  em adultos

## Oncocirurgia

## Diagnóstico histológico (biópsia)

Avalie o paciente com base nos sintomas:

- Linfonodos aumentados, emagrecimento, massa palpável  
Diagnóstico histológico: biópsia Estadiamento com TC / PET-CT Tratamento oncológico multidisciplinar

## Mapas Mentais



Fluxo: Abdome agudo

\* Dor súbita → avaliar localização

+ FID: apendicite?

+ HD: colecistite?

+ Epigástrio: pancreatite/perfuração?

Exames: leucograma, amilase/lipase, USG, TC

Conduta cirúrgica se:

+ Instabilidade

+ Sinais peritonite

+ Imagem compatível

## Trauma ABCDE

Avalie o paciente com a sequência ABCDE:

- A: Vias aéreas + proteção cervical
- B: Ventilação – inspeção, oximetria, ausculta
- C: Circulação – pulso, perfusão, reposição volêmica
- D: Déficit neurológico – escala de Glasgow
- E: Exposição – despir o paciente, prevenir hipotermia

## Checklist Final

✓ [ ] ABCDE do trauma ✓ [ ] Diferença entre hérnia direta e indireta ✓ [ ] Diagnóstico diferencial de abdome agudo ✓ [ ] Manejo da pancreatite aguda ✓ [ ] Parkland na ponta da língua ✓ [ ] Profilaxias perioperatórias (TEP, ATB) ✓ [ ] Conduta na colecistite e apendicite

## Dicas Resumed™

- Trauma SEMPRE cai — saiba o ABCDE de olhos fechados
- Abdome agudo tem pegadinhas — decore os sinais clássicos (Murphy, Blumberg, etc.)
- Hérnia estrangulada = cirurgia na hora. Não vacila.
- Queimadura com >20% = internação + Parkland. Simples e direto.

- Profilaxia perioperatória pode salvar 1 questão fácil.

## **Referências**

Obrigatórias:

- Sabiston – Tratado de Cirurgia (21ª ed.)
- Schwartz – Princípios de Cirurgia
- ATLS – Manual do Trauma
- Protocolos MS – Queimaduras, TEP, antibióticos